

Les adénopathies cervicales

PLAN

- I. Introduction
- II. Diagnostic positif
- III. Diagnostic différentiel
- IV. Diagnostic étiologique

I- Introduction

I- INTRODUCTION

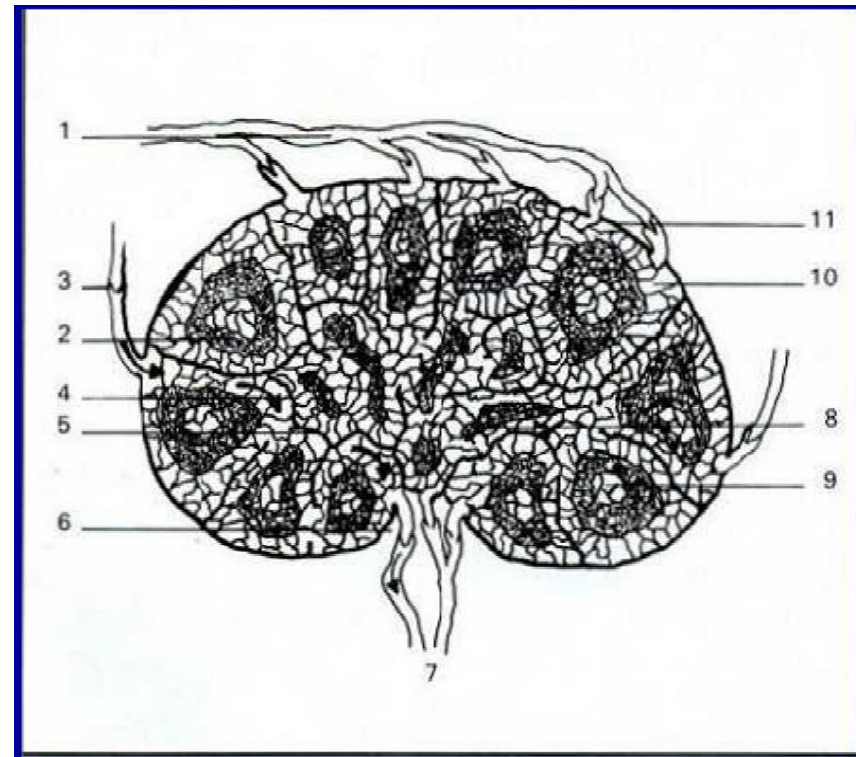
1- Généralités

- Les adénopathies cervicofaciales sont fréquentes et d'étiologie très variée. Il s'agit souvent de maladies infectieuses chez l'enfant et l'adulte jeune, mais elles font craindre des pathologies cancéreuses après 40 ans.
- Un interrogatoire rigoureux et un examen clinique soigneux sont systématiques et permettent souvent une orientation diagnostique.
- Mais la certitude n'est obtenue qu'à l'aide d'examens complémentaires et parfois le prélèvement ganglionnaire à visée histologique s'avère nécessaire.

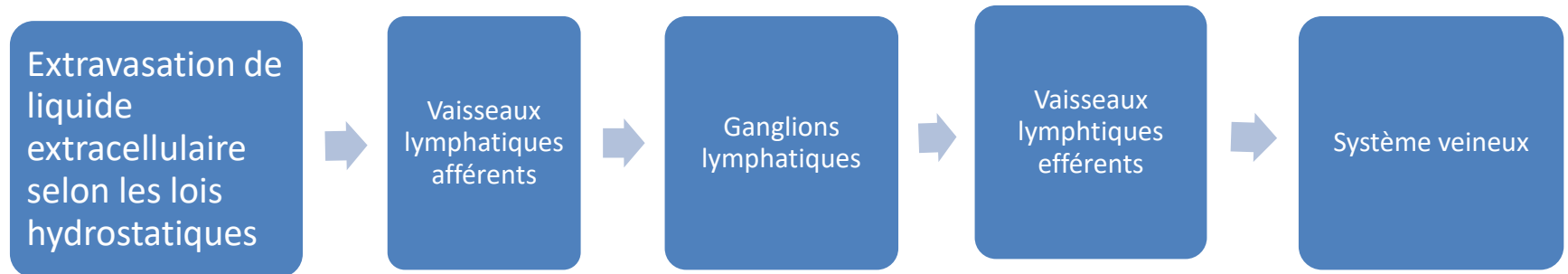
2- Rappels histologiques

- Ganglion lymphatique:
Amas de lymphocytes groupés en structures encapsulées et organisées.

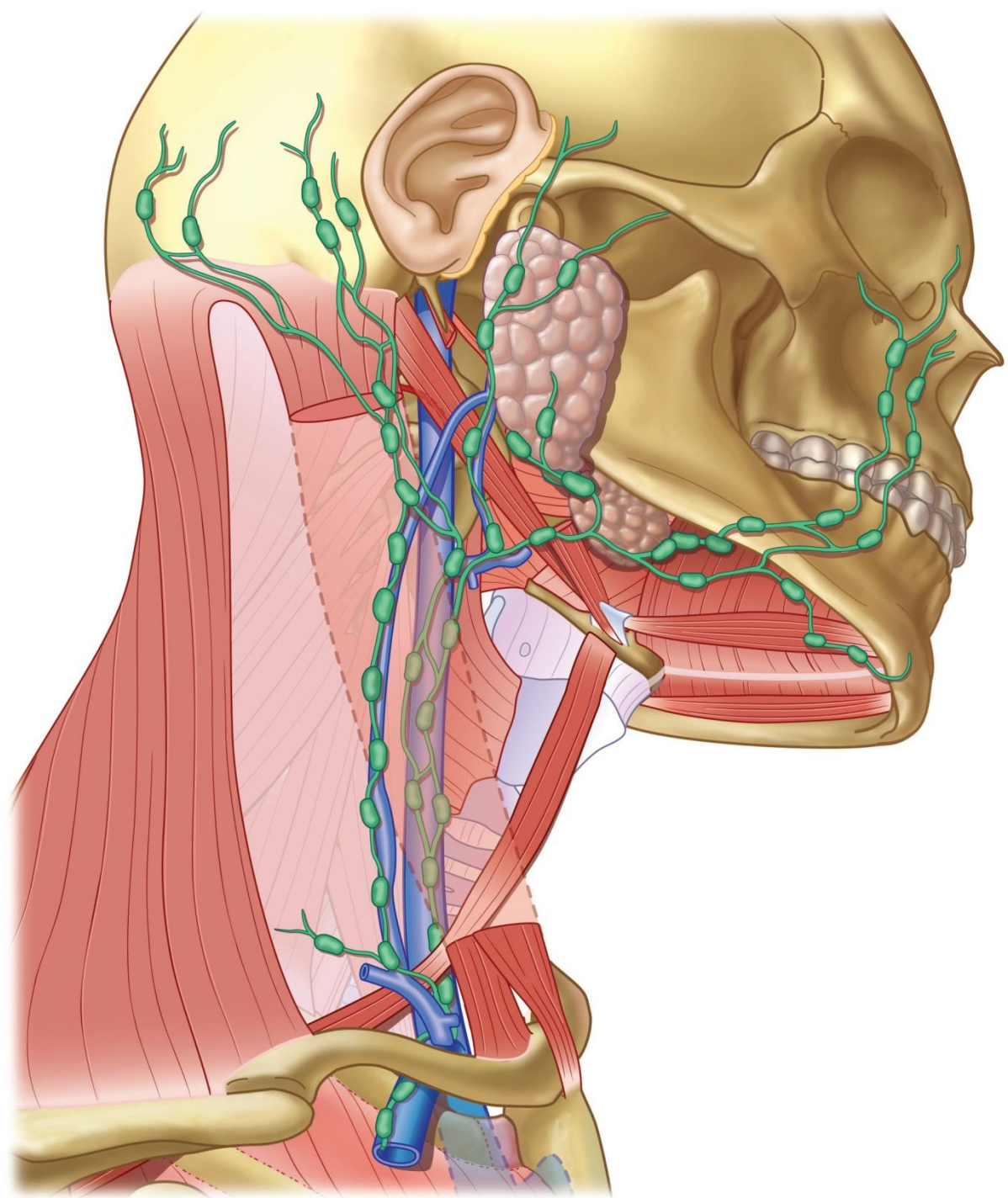
Organes ronds ovales ou en forme d'haricots, de taille variable, situés sur le trajet des gros vaisseaux lymphatiques.

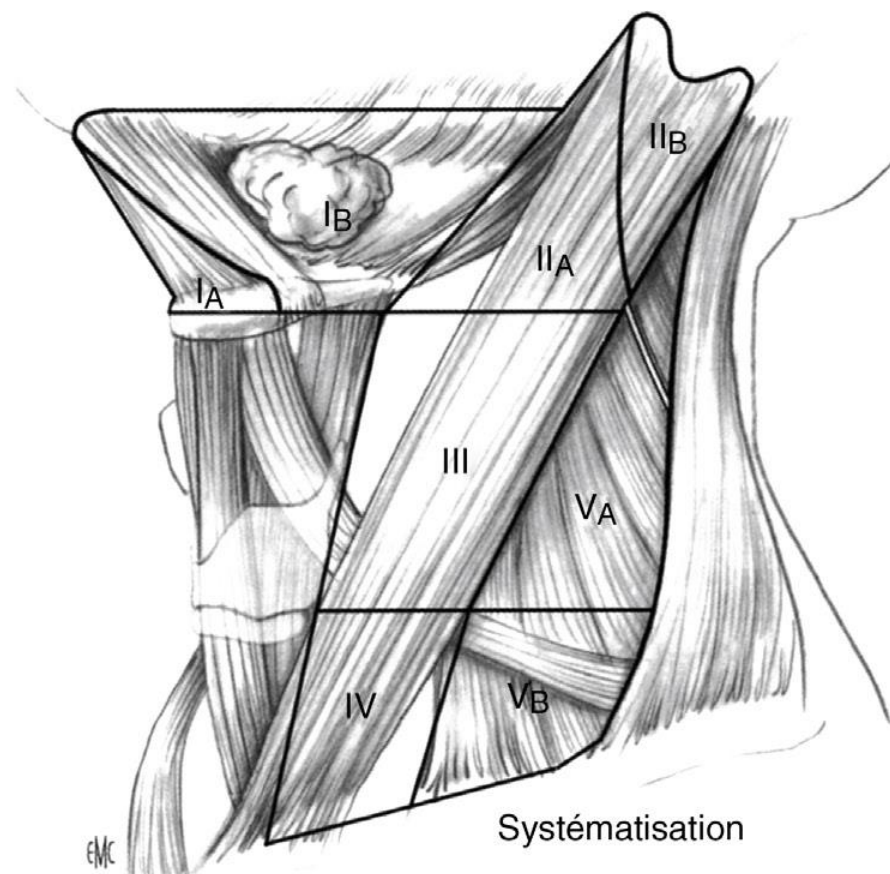
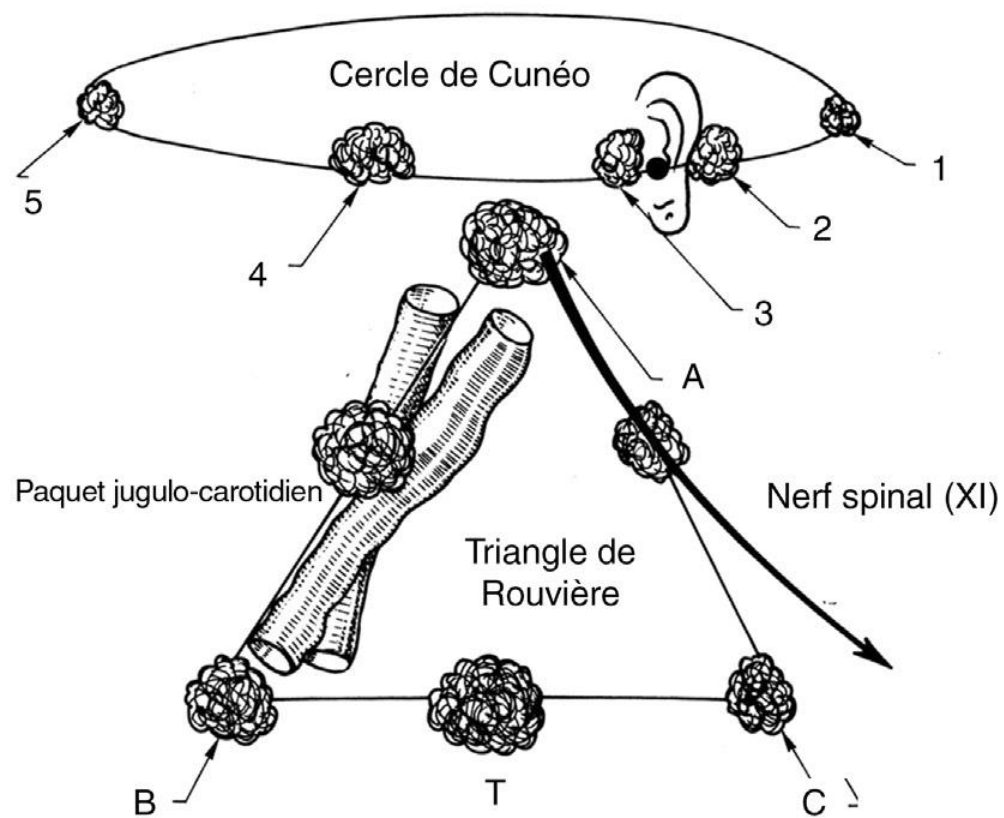


Système vasculaire lymphatiques lymphatique



3- Rappels anatomiques





II- Diagnostic positif

A- EXAMEN CLINIQUE

1- Interrogatoire

- **Age du patient**
- **Éléments liés à l'adénopathie:**
 - circonstances de découverte de l'adp fortuite ou lors d'un examen médical
 - Date d'apparition récente ou depuis plusieurs semaines
 - Évolution: rapide, progressive dans un contexte infectieux avec douleur ou sans signes associés.
- **Le pays d'origine du patient**
 - Maghreb, Asie, Afrique: certaines pathologies sont plus fréquentes
- **Contact avec des animaux**
 - Notion de manipulation, morsure, griffe dans le territoire de drainage de l'adp
- **Séjour dans un pays tropical**
- **Les antécédents du patients**
 - Radiothérapie cervicale dans l'enfance prédispose au cancer de la thyroïde
 - Interventions cervicales antérieures en rapport avec une pathologie maligne
 - Maladie systémique en cours de traitement
 - Prise médicamenteuse
- **Hygiène et mode de vie du patient**
 - Rapports non protégés
 - Prise de toxiques
 - Intoxication éthylo-tabagique
 - État vaccinal

Signes fonctionnels

- La douleur : plus ou moins importante ou simple gêne lors des mouvements de torsions de la tête ou douleur vive nocturne.

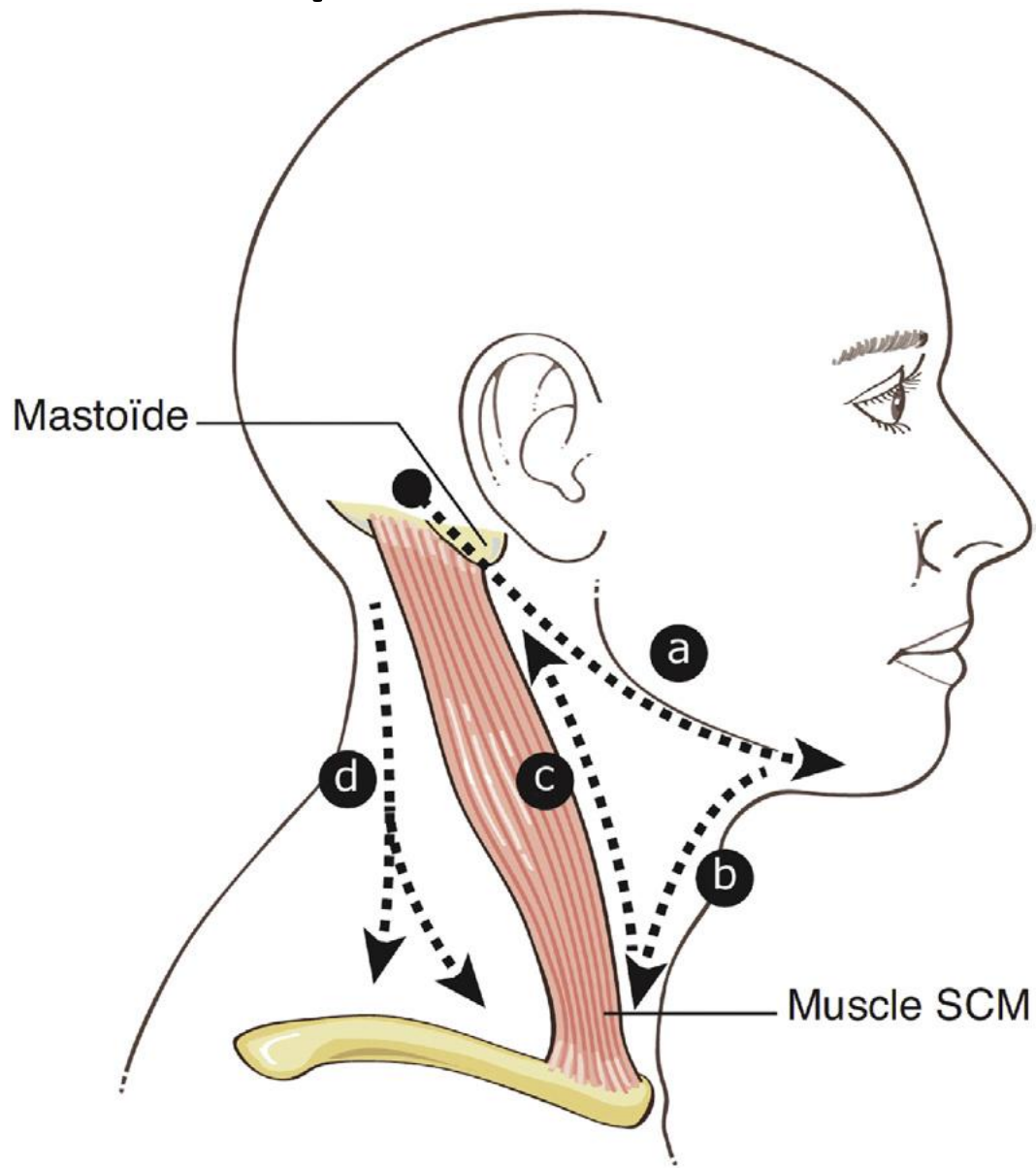
D'autres signes vont orienter vers une pathologie des VADS:

- Oodynophagie
- Dysphagie
- Hypersialorrhée
- Une otalgie réflexe

2-Examen local

- L'inspection et la palpation de la région cervicale apportent des éléments précieux concernant l'adénopathie.
- Palpation minutieuse, tête fléchie en avant pour obtenir un bon relâchement musculaire cervical.

Palpation du cou



Caractéristiques de l'adénopathie

- Siège
- Taille
- Nombre
- Consistance
- Adhérence
- Aspect de la peau en regard de l'adénopathie

3- Examen locorégional

- Examen cutané de la région cervico-faciale, du cuir chevelu.
- Palpation de la glande thyroïde et des régions parotidiennes.
- Examen des VADS: à la recherche d'une lésion.
- Palpation buccale et pharyngée et la palpation bidigitale des glandes salivaires et du plancher buccal. (base de la langue)

4- Examen général

- Palpation systématiques des aires ganglionnaires extracervicales: axillaires, épitrochléens et inguinales.
- L'atteinte de plusieurs sites ganglionnaires permet d'évoquer une pathologie générale.

II- Diagnostic positif

B- BILAN PARACLINIQUE

Bilan minimal

- Biologie: NFS, VS, CRP, Fibrinogène
 - à la recherche d'un syndrome inflammatoire ou infectieux
- IDR à la Tuberculine
 - À la recherche d'une tbc
- Rx Tx
 - Élargissement du médiastin, opacité pulmonaire...
- Échographie cervicale
 - Confirme l'adp
 - Préciser la forme: ovale, arrondie
 - structure : kystique, solide, homogène, hétérogène
 - Vascularisation: hypervascularisée ? Hile vasculaire normal ou non
 - Retrouve même des adp infracliniques

Examens complémentaires

- Demandés en fonction des résultats obtenus par le bilan « minimal »
- Biologie:
 - ❑ Sérologie: VIH, EBV, toxoplasmose, rubéole, griffe du chat, CMV, Syphilis.
 - ❑ PCR : à partir du liquide de ponction ganglionnaire dans le bilan des adénopathies infectieuses.

- Imagerie

- TDM cervicale:

- demandée devant une suspicion de lésion maligne, devant une adénopathie volumineuse
 - avant chirurgie pour juger l'opérabilité.
 - Avec injection de produit de contraste
 - Permet de préciser les caractéristiques de l'adénopathie: taille, forme, limites, présence d'une nécrose et rapport avec les structures cervicales adjacentes

❑IRM : son intérêt réside dans

- l'analyse de la lésion tumorale maligne responsable de l'adénopathie
- la recherche de la tumeur maligne primitive devant une adénopathie métastatique pour laquelle l'examen initial n'a pas mis en évidence une lésion

❑TEP-TDM

- Traceur radiomarqué 18 FDG
- Recherche de tumeur maligne primitive et bilan initial des lymphomes.

□ Endoscopie

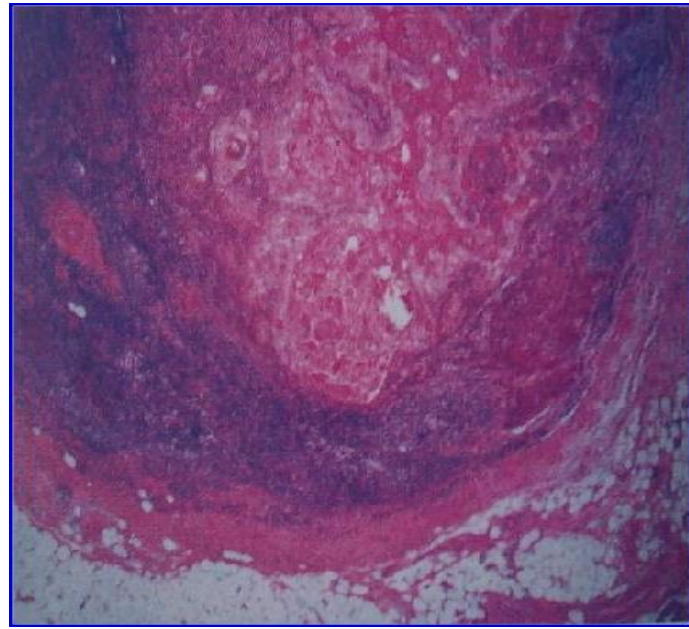
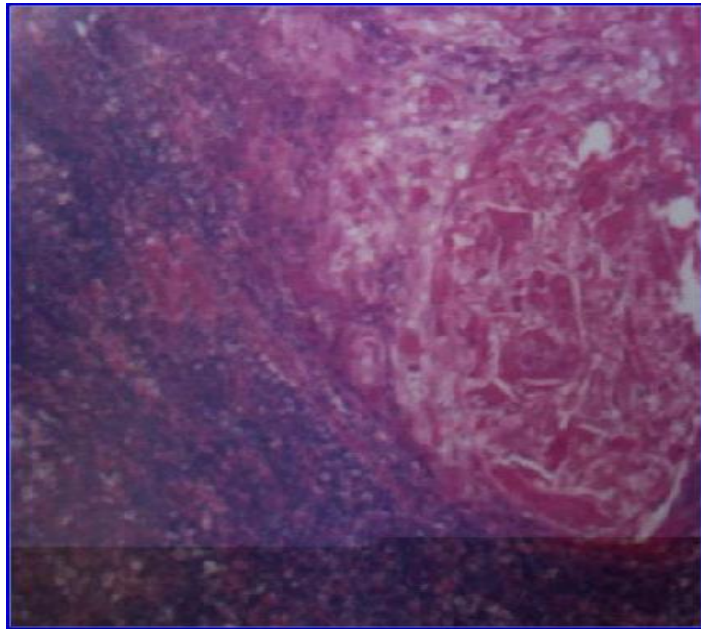
- Biopsie d'une lésion découverte lors de l'examen ORL
- Adénopathie manifestement maligne sans porte d'entrée
- Permet examen complet de tout le pharynx et le larynx
- Recherche de tumeur synchrone

❑ ponction cytologie

- Geste facile à réaliser
- Sans complication
- Analyse du frottis réalisé: adénopathie tumorale ou non.

❑ Adénectomie

- Exérèse chirurgicale de la totalité de l'adénopathie
- Examen microbiologique et anatomopathologique
- L'examen extemporané peut être utile et dépend du contexte utile -> évidemment ganglionnaire adapté.



Coupes histo-pathologiques d'un ganglion envahi de cellules carcinomateuses lors d'un carcinome épidermoïde des VADS

III- Diagnostic différentiel

Diagnostic différentiels

Structures anatomiques

- Hypertrophie de l'apophyse transverse de l'Atlas
- Bulbe carotidien athéromateux
- Grande corne de l'os hyoïde proéminente
- Ptose de la glande sub-mandibulaire

Tuméfaction cervicales latérales

- Tumeurs congénitales
 - Kystes et fistules du cou
 - Lymphangiome kystique
- Tumeurs vasculaires
 - Anévrisme carotidien
 - Fistule jugulo-carotidienne -> Thrill
 - Paragangliome carotidien
- Tuméfactions des glandes salivaires
- Nidules thyroïdiens
- Actinomyose cervicofaciale

Tumefactions cervicales médianes

- Grenouillette
- Kyste dermoïde
- Kyste thréo-glosse
- Nodule thyrôïdien isthmique
- Lipomes

III- diagnostic étiologique

III- diagnostic étiologique

A- INFECTIEUSES

A- Adénopathies cervicales infectieuses

- Bactériennes
- Foyer infectieux initial:
 - atteinte cutanée, plaie griffure , eczéma surinfecté, impétigo, furoncle
 - Infections rhinopharyngées et dentaires
 - L'évolution se fait classiquement vers la guérison
 - Aggravation: le ganglion augmente de taille, douleur et réaction inflammatoire en regard de la peau

Tuberculose

- *Mycobacterium tuberculosis hominis*
- Résurgence de la tbc depuis 10 ans
- Populations migrantes et sujets infectés VIH
- Localisation ganglionnaire cervicale 60 à 80%
- Début insidieux, petite masse cervicale dure alertant le patient
- L'évolution se fait vers l'apparition d'une masse cervicale plus importante (confluence de plusieurs ganglions)
- Paraclinique: IDR ++ (90% des cas), RX Tx, examen direct, cultures (5 à 6 semaines)

Syphilis

- *Treponema pallidum*
- I aire: incubation 20 jours, chancre primaire
exulcération indurée de la muqueuse oropharyngée
précédant d'une semaine les adénopathies satellites
dont une est généralement plus volumineuse, indolore
et mobile
- II aire: rare, se manifeste par une éruption maculo-
papuleuse et poly-adénopathies cervicales fermes et
indolores
- Sérologie: TPHA, VDRL
- TT: Pénicilline 2,4 MU

Infection virales

- MNI: EBV
- Poluadénopathie cervicale
- Ganglions de volume variable, fermes, sensibles de localisation uni ou bilatérale n'évoluant jamais vers la suppurations
- Angine érythémato-pultacée, pseudomembraneuse, fièvre, asthénie, splénomégalie
- Adénopathies persistantes chez sujet jeune: évoquer MNI
- MNI-test

VIH

- 15 jours à 3 mois après la contamination:
Adénopathies cervicales et axillaires
disséminées avec fièvre, myalgies et dysphagie
douloureuse.
- Sérologie
- Apparition d'adp unilatérale: infection
opportuniste

- Autres infections virales:
- CMV
- Rubéole
- Rhinovirus, VRS
- Parasitoses
- Toxoplasmose: adp cervicles de volume modéré